

1. L'athérosclérose affecte uniformément toutes les artères.	1. Faux
2. Les plaques athéromateuses se forment principalement à proximité des bifurcations artérielles.	2. Vrai
3. L'HTA et le diabète favorise l'athérosclérose en augmentant la perméabilité de l'endothélium aux lipoprotéines.	3. Vrai
4. L'intima est principalement infiltrée de lipides et de cellules inflammatoires dans l'athérosclérose.	4. Vrai
5. Les cellules musculaires lisses se transforment en macrophages dans l'athérosclérose.	5. Faux
6. La média des artères est atrophiée à cause de la disparition des cellules musculaires lisses dans l'athérosclérose.	6. Vrai
7. Les symptômes aigus de l'athéromatose sont dus à une réduction importante de la lumière artérielle.	7. Faux
8. L'oxyde nitrique (NO) est un gaz vasodilatateur produit par les plaquettes.	8. Faux
9. L'endothélium est une surface adhérente pour les leucocytes.	9. Faux
10. Le NO est produit en permanence dans le système cardiovasculaire.	10. Vrai
11. Les macrophages s'organisent en stries graisseuses dans les lésions d'athéromatose de type I.	11. Faux
12. Les plaques athéromateuses de type II sont caractérisées par des dépôts lipidiques situés sous l'intima.	12. Faux
13. On retrouve des lésions thrombotiques dans les plaques d'athérome de type VI.	13. Vrai

14. Les plaques athéromateuses de type III sont généralement présentes dès l'adolescence.	14. Vrai
15. Les plaques athéromateuses de type IV sont principalement constituées de lipides intracellulaires.	15. Faux
16. Les capillaires issus des vasa-vasorum prolifèrent au sein des plaques athéromateuses de type IV.	16. Vrai
17. La lumière de l'artère diminue principalement à cause de l'accumulation de lipides extracellulaires dans les plaques athéromateuses de type V.	17. Vrai
18. La lésion de type IV est typique de l'angor stable.	18. Faux
19. La lésion de type VI est typique de l'infarctus myocardique ou de l'angor instable.	19. Vrai
20. La lésion de type VII est principalement composée de lipides extracellulaires.	20. Faux
21. La lésion de type VIII contient principalement du collagène.	21. Vrai
22. Les plaques athéromateuses de type VIII sont plus stables que celles de type V et VI.	22. Vrai
23. Les plaques athéromateuses de type VIII sont moins fréquentes chez les personnes âgées.	23. Faux
24. La thrombose dans les plaques athéromateuses est principalement due à une érosion de l'intima.	24. Vrai
25. La lumière de l'artère est diminuée par la plaque d'athérome dans les lésions de type IV.	25. Faux
26. La fibrinolyse spontanée peut faire régresser les lésions athéromateuses de type VI.	26. Vrai
27. L'ADP est libéré par les plaquettes activées et active d'autres plaquettes.	27. Vrai

28. L'épaississement de la cape fibreuse dans les plaques athéromateuses de type V entraîne une diminution de la lumière de l'artère.	28. Vrai
29. Les symptômes de l'angor stable sont principalement dus à une réduction de 50% de la lumière artérielle.	29. Faux
30. La thromboplastine tissulaire active la cascade de coagulation et provoque la formation d'un caillot de fibrine.	30. Vrai
31. La fibrinolyse spontanée est induite par l'activateur tissulaire du plasminogène produit par les cellules musculaires lisses.	31. Faux
32. Tous les facteurs de risque cardiovasculaires sont modifiables.	32. Faux
33. Les hommes sont plus à risque de développer une maladie cardiovasculaire que les femmes.	33. Vrai
34. Les antécédents familiaux de pathologie vasculaire après 65 ans n'augmentent pas le risque cardiovasculaire.	34. Vrai
35. Un statut socio-économique bas est un facteur de risque cardiovasculaire modifiable.	35. Faux
36. Un cholestérol total à 180mg/dl n'est pas un facteur de risque cardiovasculaire.	36. Vrai
37. L'IMC est calculé en divisant le poids en kg par la surface corporelle en m ² .	37. Faux
38. Une glycémie à jeun normale ne réduit pas le risque cardiovasculaire.	38. Faux
39. La mortalité de l'infarctus est 5x supérieure chez les diabétiques de type II par rapport aux non diabétiques.	39. Vrai
40. L'activité physique régulière réduit de moitié l'incidence de la maladie coronaire.	40. Vrai

41. Une pression pulsée inférieure à 60mmHg chez le sujet âgé est un facteur de risque cardiovasculaire.	41. Faux
42. L'hypertrophie ventriculaire gauche est associée à un risque accru de maladie cardiovasculaire.	42. Vrai
43. L'épaississement de l'intima-média de la carotide de 0,5mm est un facteur de risque cardiovasculaire.	43. Faux
44. Un indice bras-cheville inférieur à 0,9 est un facteur de risque cardiovasculaire.	44. Vrai
45. Un patient avec une filtration glomérulaire à 80ml/min/1,73m ² est plus à risque de maladie cardiovasculaire.	45. Faux
46. Un rapport albumine/créatinine sur échantillon urinaire matinal inférieur à 30 mg/g est un facteur de risque cardiovasculaire.	46. Faux
47. Les patients en prévention secondaire ont un risque réduit de présenter une récurrence d'accident cardiovasculaire.	47. Faux
48. Les mesures diététiques sont importantes pour réduire le risque cardiovasculaire chez les patients à risque élevé.	48. Vrai
49. Un BMI supérieur à 25 kg/m ² est associé à un risque accru de maladie cardiovasculaire.	49. Faux
50. Une circonférence abdominale supérieure à 95cm chez la femme n'est pas un facteur de risque cardiovasculaire.	50. Faux
51. Les patients ayant présenté un AIT doivent faire l'objet d'une prévention secondaire.	51. Vrai
52. Des triglycérides à 120mg/dl dans le sang n'augmentent pas le risque cardiovasculaire.	52. Vrai
53. Une PAD supérieure à 110mmHg est considérée comme une HTA de grade 3.	53. Vrai
54. Une réduction de cholestérol total de 2% réduit les événements coronariens de 1%.	54. Faux

55. Une tension à 160/95mmHg double le risque cardiovasculaire par rapport à 120/80mmHg.	55. Vrai
56. Le tabagisme multiplie le risque cardiovasculaire par 3 chez les femmes indépendamment des autres facteurs de risque.	56. Vrai
57. Une tension inférieure à 160/90 est recommandée chez les patients à risque moyen de maladie cardiovasculaire.	57. Faux
58. Un LDL-cholestérol inférieur à 55 mg/dl est recommandé chez les patients à risque élevé de maladie cardiovasculaire.	58. Vrai
59. Un HDL-cholestérol inférieur à 40 mg/dl est recommandé chez les patients à risque élevé de maladie cardiovasculaire.	59. Faux
60. Une hémoglobine glycosylée inférieure à 7 % est recommandée chez les patients à risque élevé de maladie cardiovasculaire.	60. Vrai
61. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont recommandés chez les patients à risque moyen de maladie cardiovasculaire.	61. Faux
62. Le traitement pharmacologique classique utilisée en prévention pour les patients à risque élevé de maladies cardiovasculaires est uniquement composé de statines et d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion.	62. Faux
63. Les patients à risque moyen de maladie cardiovasculaire doivent voir leur cardiologue 3 fois par an.	63. Faux

64. L'athérosclérose affecte d'abord la média des artères.	64. Faux
65. La table SCORE ne peut pas être utilisée en prévention secondaire.	65. Vrai
66. Les symptômes de l'athéromatose sont très tardifs car la maladie ne réduit pas immédiatement la lumière de l'artère.	66. Vrai
67. L'athéromatose peut toucher les artères carotides et iliaques mais pas l'aorte.	67. Faux
68. L'athéromatose atteint fréquemment les artères coronaires mais quasiment jamais l'artère mammaire interne.	68. Vrai
69. L'intima infiltrée de lipides et de cellules inflammatoires se fibrose durant la formation de la plaque.	69. Vrai
70. Les fibroblastes ne jouent aucun rôle dans la formation de la plaque athéromateuse.	70. Faux
71. Les maladies cardiovasculaires sont la 2 ^{ème} cause de décès en Belgique, juste derrière les cancers.	71. Faux
72. La migration des cellules musculaires lisses amincit la média dans l'athéromatose.	72. Vrai
73. Une artère angiographiquement normale peut cacher une athéromatose légère mais pas prononcée.	73. Faux
74. L'artère athéromateuse devient ovale pour préserver le diamètre de sa lumière.	74. Vrai
75. L'endothélium produit des substances vasoconstrictrices, des facteurs de croissance et des cytokines.	75. Vrai
76. L'endothélium forme une surface non-thrombogène pour les plaquettes par la production de molécules anti-agrégantes et fibrinolytiques.	76. Vrai

77. Les endroits où l'intima est amincie sont des sites préférentiels pour les plaques athéromateuses.	77. Faux
78. Les cellules spumeuses sont des polynucléaires chargés de gouttelettes de lipides.	78. Faux
79. L'intima est épaissie et sa perméabilité est accrue au niveau des sites de bifurcation des artères.	79. Vrai
80. La lésion de type III est le 1 ^{er} stade de la plaque athéromateuse classique.	80. Vrai
81. La lumière de l'artère est diminuée dans les lésions d'athéromatose de type IV.	81. Faux
82. Les dépôts de lipides extra-cellulaires apparaissent à partir des lésions de type III.	82. Vrai
83. La lésion de type IV est constituée d'un noyau lipidique libre de cellules entouré de cellules inflammatoires et recouvert d'une fine couche de tissu conjonctif.	83. Vrai
84. Dans l'athéromatose de type V, la protrusion de la lésion dans la lumière de l'artère altère le flux sanguin laminaire normal et le rend turbulent.	84. Vrai
85. On retrouve des hémorragies dans la lésion athéromateuse de type IV.	85. Faux
86. Les sites de rupture des plaques sont souvent situés à la frontière entre l'intima normale et la plaque.	86. Vrai
87. La rupture de la plaque athéromateuse survient généralement au stade V.	87. Vrai
88. La fissuration de la plaque aboutit à une agrégation plaquettaire immédiate et à la formation d'un thrombus.	88. Vrai
89. L'âge supérieur à 55 ans est un facteur de risque cardiovasculaire chez la femme.	89. Faux

90. Le LDL-cholestérol doit être inférieur à 115 mg/L.	90. Faux
91. Les femmes ont un taux de HDL-cholestérol naturellement plus élevé.	91. Vrai
92. Les facteurs de risque cardiovasculaires cumulés ont un effet multiplicatif sur le risque global.	92. Vrai
93. Les patients qui présentent une rétinopathie avancée doivent faire l'objet d'une prévention secondaire.	93. Vrai
94. Les patients souffrant d'HTA de grade 3 ont un risque élevé de maladies cardiovasculaires même sans aucun autre facteur de risque.	94. Vrai
95. Les patients qui cumulent 3 facteurs de risque ou qui présentent une atteinte des organes cibles ont d'office un risque élevé à très élevé de maladies cardiovasculaires peu importe leur niveau de tension artérielle.	95. Vrai
96. Pour convertir le risque cardiovasculaire fatal en risque cardiovasculaire total (fatal et non fatal), il faut multiplier le risque obtenu par la table SCORE par 3 chez les femmes et par 4 chez les hommes (moins chez le sujet âgé).	96. Faux
97. La table SCORE peut être utilisée chez les sujets diabétique car elle prend en compte le taux de glucose à jeun.	97. Faux
98. L'arrêt du tabac entraîne une disparition de l'excès de risque cardiovasculaire après 3-4 ans.	98. Vrai
99. Un risque élevé de décès cardiovasculaire correspond à 5-10% de mortalité à 10 ans en l'absence de traitement.	99. Vrai
100. Un risque moyen de décès cardiovasculaire correspond à <1% de mortalité à 10 ans en l'absence de traitement.	100. Faux